



Vitamin C Infusionstherapie

Schneller fit · Schneller zurück im Leben

Sehr geehrter Patientin,
Sehr geehrter Patient,

wir erweitern unser Therapieangebot um die **Vitamin-C-Infusionstherapie**, eine gezielte Möglichkeit, den Körper genau dann zu unterstützen, wenn er besonders gefordert ist.

Nach einer Operation läuft die Regeneration auf Hochtouren: Gewebe muss sich erneuern, Wunden schließen, das Immunsystem stabil bleiben. Vitamin C ist dabei ein **zentraler Baustein**. Es unterstützt die Kollagenbildung für stabiles Gewebe, trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei und begleitet den natürlichen Heilungsprozess. Auch vorbeugend, etwa bei erhöhter körperlicher Belastung, ist eine optimale Versorgung sinnvoll.

Der entscheidende Unterschied in der Vitamin-C-Versorgung

Oral aufgenommenes Vitamin C ist durch die begrenzte Aufnahmefähigkeit des Darms eingeschränkt. Lediglich ca. 10–20 % erreichen tatsächlich den Blutkreislauf. Eine intravenöse Verabreichung umgeht diese natürliche Barriere: Hochdosiertes Vitamin C gelangt direkt in Ihre Blutbahn und steht dem Körper nahezu vollständig zur Verfügung. **Effizient, gezielt und ohne unnötige Verluste.**

IHRE VORTEILE

- › Direkte Aufnahme über die Blutbahn
- › Deutlich höhere Dosierung möglich
- › Sofortige Versorgung des Körpers
- › Umgehung des Magen-Darm-Trakts
- › Minimaler Vitaminverlust

NACH OPERATIONEN

- › Beschleunigte Wundheilung
- › Reduktion von Entzündungen
- › Weniger postoperative Schmerzen
- › Stärkung des Immunsystems
- › Schnellere Erholung & weniger Komplikationen

DAUER

ca. 30 Minuten pro Infusion

WIEDERHOLUNGEN

4–5 Infusionen über 4–6 Wochen

Vor jeder Behandlung nehmen wir uns Zeit für Sie: In einem ausführlichen Vorgespräch klären wir Ihre individuelle Situation und informieren Sie transparent über die Therapie.

Die Vitamin-C-Infusion ist in der Regel **sehr gut verträglich**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen und Terminwünschen jederzeit zur Verfügung.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Game Ready – Kältekompessionstherapie

Schneller erholen · Schneller zurück im Leben

**Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,**

um ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen, ist nach einer Operation oder Verletzung eine professionelle Nachbehandlung entscheidend. Schwellungen, die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verursachen, gehören dabei zu den häufigsten Herausforderungen.

Die Kälte- und Kompressionssterapie reduziert Schwellungen gezielt, fördert den Lymphabfluss und lindert Schmerzen spürbar – für eine rasche Schmerzlinderung und verbesserte Beweglichkeit.

Warum Kälte und Kompression so wirksam sind

Nach einer Operation oder Verletzung sind Schwellung und Schmerz natürliche Körperreaktionen – sie verlangsamen jedoch die Heilung. Kälte verengt die Gefäße und reduziert Entzündungsreize, während Kompression Flüssigkeitsansammlungen aktiv abtransportiert.

Game Ready vereint beide Effekte in einem System: gleichzeitige Kühlung und wechselnder Kompressionsdruck – **effizient, angenehm** und **ohne Nebenwirkungen**.

IHRE VORTEILE

- › Gezielte Reduktion von Schwellungen
- › Förderung des Lymphabflusses
- › Schnelle und spürbare Schmerzlinderung
- › Verbesserte Beweglichkeit bereits nach wenigen Anwendungen
- › Von Patientinnen und Patienten als sehr angenehm empfunden

NACH OPERATIONEN

- › Postoperative Schmerzreduktion & Entwässerung
- › Schnellere Rückkehr zur vollen Beweglichkeit

DAUER

ca. 10 Minuten pro Anwendung

WIEDERHOLUNGEN

3-5 Anwendungen alle 3-5 Tage

Damit Ihr Aufwand so gering wie möglich ausfällt, bieten wir in unserer Ordination eine ganzheitliche Betreuung – damit Sie sich so einfach wie möglich regenerieren können.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Extrakorporale Stoßwellentherapie

Nichtinvasiv · Ambulant · Zurück zum Sport

**Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,**

die extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) setzt hochenergetische Stoßwellen gezielt im Gewebe ein, um Schmerzen zu lindern und die Regeneration zu aktivieren – ganz **ohne Operation, ohne Narkose, ohne Ausfallzeiten.**

Speziell nach Bandrekonstruktionen sowie bei vorliegenden Knorpelschädigungen im Gelenksbereich kann das Endergebnis gravierend optimiert werden und so eine raschere Genesung erfolgen. Mit diesen nichtinvasiven Methoden können sowohl Gelenke nach Verletzungen als auch Gelenke bei vorliegenden degenerativen Veränderungen behandelt werden. Zusätzlich können damit auch muskuläre Probleme behoben werden.

Die Rückkehr zum Sport wird deutlich beschleunigt.

Wie wirkt die Stoßwellentherapie?

Hochenergetische Stoßwellen werden gezielt auf das betroffene Gewebe geleitet. Sie regen die Durchblutung an, lösen Verkalkungen, aktivieren Selbstheilungskräfte und wirken entzündungshemmend. Das Ergebnis: **weniger Schmerzen, mehr Beweglichkeit – nachhaltig.**

ANWENDUNGSGEBIETE

- › Muskuloskelettale Erkrankungen
- › Degenerative Erkrankungen (Bandscheibenvorfall, Spondylarthrose)
- › Arthrose (Knie, Hüfte, Hände, Schulter, Ellenbogen)
- › Sehnenüberlastungssyndrome & chronische Entzündungen
- › Sportverletzungen & nach Operationen (Kreuzband, Knorpel)
- › Muskelverspannungen, Radikulopathien & Lumbalgie

BEHANDLUNGEN

5 Einheiten als Block

WIEDERHOLUNGEN

Alle 10–14 Tage · ca. 5 Min. pro Sitzung

Wussten Sie ? – Wir kombinieren die Stoßwellen- und Magnetoliththerapie

Beide Therapien ergänzen sich optimal: Die Stoßwelle aktiviert die Selbstheilung, die Magnetoliththerapie vertieft die Regeneration auf Zellebene. Gemeinsam erzielen wir für Sie das **bestmögliche Behandlungsergebnis** – schneller, nachhaltiger, schonender. Mehr dazu auf Seite 2.



Dr. El Marto
Knie- und Sportverletzungen

OA Dr. med. univ. Shady El Marto WDM
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie | Facharzt für Unfallchirurgie
Am Hof 11 Top 9 | 1010 Wien | Tel.: +43 664 328 44 65
ordination@dr-elmarto.at | www.dr-elmarto.at

Extrakorporale **Magnetolithherapie**

Nahezu schmerzfrei · Ambulant · Tiefe Zellregeneration

**Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,**

die Magnetolithherapie nutzt hochfrequente Magnetfelder, um Regenerationsprozesse direkt auf Zellebene anzuregen. Sie ist nahezu vollständig schmerzfrei, hinterlässt keine Ausfallzeiten und eignet sich ideal zur Unterstützung nach Operationen oder bei chronischen Beschwerden.

Wie wirkt die Magnetolithherapie?

Hochfrequente Magnetfelder (bis 3 Tesla) durchdringen das Gewebe tief und aktivieren dort die Zellregeneration: Stoffwechsel wird angeregt, Entzündungsprozesse gehemmt, Schmerzsignale reduziert. Die Wirkung ist tief, nachhaltig und vollkommen ohne äußere Einwirkung auf die Haut.

ANWENDUNGSGEBIETE

- › Chronische Schmerzen & Muskelverspannungen
- › Rückenschmerzen, Lumbalgie, Radikulopathien
- › Degenerative Gelenkerkrankungen & Arthrose
- › Sportverletzungen & nach Operationen
- › Gelenke nach Verletzungen & bei Knorpelschäden
- › Sehnenüberlastungssyndrome (nicht bei Implantaten*)

BEHANDLUNGEN

6–8 Einheiten als Block

WIEDERHOLUNGEN

Alle 3–5 Tage · ca. 8–10 Min. pro Sitzung

Stoßwellen- und Magnetolithherapie - unser kombiniertes Therapiekonzept

Wir bieten Ihnen beide Therapien gemeinsam und abgestimmt aufeinander, individuell auf Sie zugeschnitten. Während die Stoßwelle mechanische Impulse setzt und Heilungsprozesse anstößt, vertieft die Magnetolithherapie die Wirkung auf Zellebene.

Das Ergebnis ist **mehr als die Summe beider Teile**

** Magnetolithherapie nicht geeignet bei Herzschrittmacher, Defibrillator, Hörgeräten oder nicht MR-tauglichen Implantaten.*



Early Active Rehab

Ganzheitliche Rehabilitation · Medizinische Aufsicht

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

um ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen, ist im Anschluss an eine Operation oder Verletzung eine professionelle Physiotherapie sowie ein gezieltes Training unter Anleitung unserer Experten mit Erstellung eines individuellen Trainingsplans erforderlich. Damit Ihr Aufwand so gering wie möglich ausfällt, bieten wir in unserer Ordination eine ganzheitliche Betreuung, um es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, sich zu regenerieren.

Unser mit Experten aus Sportwissenschaft und Physiotherapie erarbeitetes Konzept - **Early Active Rehab** - besteht aus 3 Phasen und zielt auf die Rehabilitation sowie vor allem die Prävention weiterer Verletzungen ab. Es ermöglicht für jeden Patienten die Erstellung einer individuellen Therapie- und Trainingsgestaltung unter medizinischer Aufsicht.

Unsere Ziele für Ihre Rehabilitation

Dieses Konzept ermöglicht Ihnen eine ganzheitliche, an Ihre Bedürfnisse angepasste Rehabilitation unter einem Dach und unter **ständiger medizinischer und therapeutischer Kontrolle**.

REHABILITATIONSZIELE

- › Wiederaufbau der Muskulatur
- › Langfristige Stabilisierung der Gelenke
- › Prävention weiterer Verletzungen
- › Aufbau der Knochendichte
- › Erhöhung der Leistungsfähigkeit
- › Gewichtsmanagement & Bodyforming

DIE 3 PHASEN

Phase 1 – OA Dr. Shady El Marto **+43 664 328 44 65**

Phase 2 – Heilmassage **+43 650 4426 076**

Physiotherapie **+43 650 3403 411** oder **+43 690 1064 7645**

Phase 3 – Personal Health Coach **+43 680 2427 900**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen und Terminwünschen jederzeit zur Verfügung.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopie des Schultergelenks

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopie des Schultergelenks.**

Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

Sofortmaßnahmen in den ersten Tagen

Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung isometrischer Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Verbandsanordnung bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht.**

WEITERE MAßNAHMEN

- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie** – wir empfehlen unser **Early Active Rehab** (exklusiv in unserer Ordination)
- › **Stoßwellentherapie** sowie **Magnetolith-Therapie** zur Unterstützung der Heilung
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Beweglichkeit
- › **Nahtentfernung** 10–14 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Schultergelenks: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung nach **Arthroskopie** des **Schultergelenks**

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen ist eine Arthroskopie des Schultergelenks durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Bitte verwenden Sie, wenn nicht anders kommuniziert, die ersten **2 Wochen** den angelegten Verband. Zum Duschen kann die Verbandsanordnung selbstverständlich abgenommen werden.

Ihr Rehabilitationsplan im Überblick

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Die Empfehlungen basieren auf der rezenten Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses.

AB DER 1. WOCH

Beginn mit der **Magnetolithapie** (EMTT) – ca. 6–8 Einheiten alle 3–5 Tage in der Ordination.
Zu Hause selbständige Anwendung von Coolpacks. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCH

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie** (ESWT) – 5 Einheiten im 10–14 Tagesabstand in der Ordination.
Die physikalische Therapie kann nun begonnen werden.

NACH 4 WOCHEN

Beginn mit **Infiltrationen** zur Optimierung der Heilung und zum Schutz des Gelenkknorpels sowie zur raschen Wiederherstellung der Gelenksschmiere.

INFILTRATIONSOPTIONEN

- › **ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure** - bei dieser hilfreichen Maßnahme wird körpereigenes, wachstumsfaktorreiches Plasma (ACP/PRP) mit Hyaluronsäure gemischt und in Gelenke gespritzt wird. Diese Kombination wirkt synergistisch: Die Hyaluronsäure schmiert das Gelenk, während ACP-PRP Entzündungen hemmt und die Regeneration von Knorpel, Sehnen und Bändern fördert
- › **Isolierte Infiltrationen mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung bei Ersatz des vorderen Kreuzbandes

Wochen 1–2 · Sofortmaßnahmen & erste Therapieschritte

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen ist ein arthroskopisch assistierter Ersatz des vorderen Kreuzbandes durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Generell gilt: aktives Strecken des Beines in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** des Beines stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie bis zur Nahtentfernung (ca. 10–14 Tage nach OP) unterstützend die Krücken und peilen Sie eine **Teilbelastung mit halbem Körpergewicht** an.

Das Tragen der **Kniegelenksorthese in Einstellung F 60 Grad** ist bis zur Nahtentfernung Tag und Nacht empfohlen. Zum Duschen kann die Schiene abgenommen werden. Die Gesamttragedauer der Orthese beträgt **6 Wochen**.

AB DER 1. WOCH

Abschwellende Maßnahmen mittels **Game Ready Rehab** (ca. 3–5 Einheiten nach OP) sowie **Magnetolithherapie** (ca. 6–8 Einheiten, alle 3–5 Tage in der Ordination).

Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines sowie isometrische Spannungsübungen mit aktivem Strecken im Kniegelenk. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCH

Beginn mit Bewegungsübungen in der geschlossenen Kette sowie Physiotherapie und Koordinationstraining unter Anleitung.

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie ESWT** (5 Einheiten alle 10–14 Tage in der Ordination).

Die **Kniegelenksorthese** kann am **Ende der 2. Woche** auf **F 90 Grad** umgestellt werden.

Fortsetzung auf Seite 2 – Rehabilitation ab Woche 4 bis zur Sportfreigabe nach 9–12 Monaten



Nachbehandlung bei Ersatz des **vorderen Kreuzbandes**

Wochen 4–52 · Sport & langfristige Rehabilitation

NACH 4 WOCHEN

Beginn mit Infiltrationen zur Optimierung der Einheilung des vorderen Kreuzbandes sowie zum Schutz des Gelenkknorpels und zur raschen Wiederherstellung der Gelenksschmiere.

Verfügbare Optionen: ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure sowie isolierte Infiltrationen mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure.

NACH 6 WOCHEN

Beginn mit vorsichtigem **Ergometerfahren** bei Beugung ab 100 Grad (geringe Watt-Zahl, geringe Trittfrequenz, hoher Sattel). Die Orthese kann konsequent weggelassen werden.

NACH 8 WOCHEN

Steigen Sie mit Nordic Walking, Schwimmen und Outdoor-Radfahren sanft wieder ein. Aquajogging und **angeleitetes Kraft-Stabilitäts-Training** durch **unsere Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen** runden das Programm ab, um Ihren Genesungsprozess optimal zu unterstützen.

NACH 12 WOCHEN

Beginn mit lockerem Laufen sowie zunehmenden **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

NACH 9 BIS 12 MONATEN

Vorsichtiger Beginn mit **Kontaktsport** (Kampfsportarten) sowie Stop-and-Go-Sportarten (Fußball, Tennis, Squash, Skifahren etc.) **nach Freigabe durch OA Dr. El Marto.**

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopisch assistierter **vorderer Kreuzbandersatz**

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopisch assistierter vorderer Kreuzbandersatz.**

Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten 3 Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht.**

WEITERE MAßNAHMEN

- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie** – wir empfehlen **Early Active Rehab** (exklusiv in unserer Ordination)
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Stoßwellen-** bzw. **Lasertherapie** zur Unterstützung der Nachbehandlung
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung (tagsüber)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Heilung

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopie des Sprunggelenks

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopie des Sprunggelenks**. Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten Tagen

Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie** – wir empfehlen **Early Active Rehab** (exklusiv in unserer Ordination)
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Stoßwellen-** bzw. **Lasertherapie** zur Unterstützung der Nachbehandlung
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung (tagsüber)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Heilung

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Sprunggelenks: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Nachbehandlung nach Arthroskopie des Sprunggelenks

Wochen 1–2 · Therapieschritte & Sport ab Woche 4

Liebe Patientin, lieber Patient,

bei Ihnen ist eine Arthroskopie des Sprunggelenks durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend zur Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **5–7 Tage unterstützend die Krücken** und peilen Sie eine Teilbelastung mit halbem Körpergewicht an.

Zum Duschen kann die Schiene abgenommen werden. Bewegungsübungen für das obere Sprunggelenk können **ab dem ersten Tag nach der OP** durchgeführt werden.

AB DER 1. WOCH

Abschwellende Maßnahmen mittels **Game Ready Rehab** (ca. 3–5 Einheiten nach OP) sowie **Magnetolithherapie** (ca. 6–8 Einheiten, alle 3–5 Tage in der Ordination).

Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines. Duschpflaster regelmäßig nach Bedarf wechseln.

AB DER 2. WOCH

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** in der Ordination. Die physikalische Therapie kann nun begonnen werden.

AB DER 4. WOCH

Beginn mit **Infiltrationen** zur Optimierung der Heilung und zum Schutz des Gelenkknorpels sowie zur raschen Wiederherstellung der Gelenksschmiere. Optionen: ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure oder isolierte Infiltration mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure.

NACH 6 WOCHEN

Beginn mit Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren im Freien, Aquajogging und muskelstabilisierenden Übungen unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

Zusätzlich Beginn mit lockerem Laufen sowie zunehmenden **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopisch assistierte **MPFL Rekonstruktion**

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopisch assistierte MPFL Rekonstruktion.**

Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten 3 Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie isometrische Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht.**

WEITERE MAßNAHMEN

- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie** – wir empfehlen **Early Active Rehab** (exklusiv in unserer Ordination)
- › **Nahtentfernung** 8–12 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Stoßwellen-** bzw. **Lasertherapie** zur Unterstützung der Nachbehandlung
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Heilung

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung bei **MPFL Rekonstruktion**

Wochen 1–2 · Sofortmaßnahmen & erste Therapieschritte

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen ist ein **arthroskopisch assistierter Ersatz des MPFL Apparates** durchgeführt worden.

Folgende Empfehlungen sind als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie bis zur Nahtentfernung (ca. 10–14 Tage nach OP) unterstützend die Krücken und peilen Sie eine **Teilbelastung mit halbem Körpergewicht** an.

Tragen der **Kniegelenksorthese F 30 Grad** bis zur Nahtentfernung Tag und Nacht empfohlen (zum Duschen abnehmbar). Gesamttragedauer: **6 Wochen**.

AB DER 1. WOCH E

Abschwellende Maßnahmen mittels **Game Ready Rehab** (ca. 3–5 Einheiten nach OP) sowie **Magnetolithherapie** (ca. 6–8 Einheiten, alle 3–5 Tage in der Ordination).

Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines sowie isometrische Spannungsübungen mit aktivem Strecken im Kniegelenk. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCH E

Beginn mit Bewegungsübungen in der geschlossenen Kette sowie Physiotherapie und Koordinationstraining unter Anleitung.

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie ESWT** (5 Einheiten alle 10–14 Tage in der Ordination).

Die **Kniegelenksorthese** kann am **Ende der 2. Woche** auf **F 90 Grad** umgestellt werden.

Fortsetzung auf Seite 2 – Rehabilitation ab Woche 4 bis zur Sportfreigabe nach 9–12 Monaten



Nachbehandlung bei **MPFL Rekonstruktion**

Wochen 4–52 · Sport & langfristige Rehabilitation

NACH 4 WOCHEN

Beginn mit Infiltrationen zur Optimierung der Einheilung des vorderen Kreuzbandes sowie zum Schutz des Gelenkknorpels und zur raschen Wiederherstellung der Gelenksschmiere.

Verfügbare Optionen: ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure sowie isolierte Infiltrationen mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure.

NACH 6 WOCHEN

Beginn mit vorsichtigem **Ergometerfahren** bei Beugung ab 100 Grad (geringe Watt-Zahl, geringe Trittfrequenz, hoher Sattel). Die Orthese kann konsequent weggelassen werden.

NACH 8 WOCHEN

Steigen Sie mit Nordic Walking, Schwimmen und Outdoor-Radfahren sanft wieder ein. Aquajogging und **angeleitetes** Kraft-Stabilitäts-Training durch **unsere Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen** runden das Programm ab, um Ihren Genesungsprozess optimal zu unterstützen.

NACH 12 WOCHEN

Beginn mit lockerem Laufen sowie zunehmenden **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

NACH 9 BIS 12 MONATEN

Vorsichtiger Beginn mit **Kontaktsport** (Kampfsportarten) sowie Stop-and-Go-Sportarten (Fußball, Tennis, Squash, Skifahren etc.) **nach Freigabe durch OA Dr. El Marto.**

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung bei **Achillessehnenrekonstruktion**

Combining der Achillessehne mit Abtragung von Exostosen

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

Bei Ihnen ist eine **Rekonstruktion der Achillessehne** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **14 Tage unterstützend die Krücken** und peilen Sie eine Teilbelastung mit halbem Körpergewicht an.

Ihnen wurde ein **Aircastwalker mit 2–3 Keilen** angepasst. Dieser sollte für **6 Wochen, Tag und Nacht** getragen werden. Es wird empfohlen, den **Aircastwalker** regelmäßig zu öffnen und den Fuß zu lüften.

1. WOCH E

Abschwellende Maßnahmen mittels **Game Ready** (ca. 3–5 Einheiten nach OP) sowie **Magnetolithherapie** (ca. 6–8 Einheiten, alle 3–5 Tage in der Ordination).

Zu Hause: Coolpacks und Hochlagerung des Beines. Duschpflaster regelmäßig nach Bedarf wechseln.

2. WOCH E

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** – 5 Behandlungen in der Ordination.

NACH 6 WOCH EN

Abnahme des Aircastwalkers und Beginn mit **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen.

AIRCASTWALKER – HINWEIS

Gesamttragedauer: **6 Wochen Tag und Nacht**. Regelmäßiges Öffnen und Lüften des Fußes empfohlen. 2–3 Keile bleiben bis zur Abnahme eingelegt.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Endergebnisses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Arthroskopisch des Kniegelenks mit Microfracturing oder Autocart

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopisches Kniegelenksmit Microfracturing oder Autocart**. Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten 3 Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle in unserer Ordination **konsequent Tag und Nacht**.

Die Motorschiene soll anfangs **täglich zwei Mal** mit der **Einstellung 0-60** angewendet werden. Dies kann von Woche zu Woche nach Rücksprache gesteigert werden.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie** – wir empfehlen **Early Active Rehab** (exklusiv in unserer Ordination)
- › **Nahtentfernung** 10–14 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Stoßwellen-** sowie **Magnetolithherapie** zur Unterstützung der Nachbehandlung
- › **Konsequente Entlastung** mit Stützkrücken und Tragen der Kniegelenksorthese bis zur Nahtentfernung (tagsüber)
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Heilung

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung nach Arthroskopie des Kniegelenks mit Microfacturing oder Autocart

Wochen 1–2 · Therapieschritte & Sport ab Woche 4

Liebe Patientin, , lieber Patient,

bei Ihnen ist eine **Arthroskopie des Kniegelenks** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend zur Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **4 Wochen** unterstützend **die Krücken** mit konsequenter Entlastung.

Nach den ersten 48 Stunden in **absoluter Streckstellung** soll das Tragen der **Kniegelenksorthese** in der **Einstellung F 30 Grad** bis zur Nahtentfernung Tag und Nacht erfolgen.

AB DER 1. WOCH

Abschwellende Maßnahmen mittels **Game Ready Rehab** (ca. 3–5 Einheiten nach OP) sowie **Magnetolithherapie** (ca. 6–8 Einheiten, alle 3–5 Tage in der Ordination).

Zu Hause: Coolpacks, Hochlagerung des Beines. Duschpflaster regelmäßig nach Bedarf wechseln.

Die Motorschiene kann ab dem zweiten Tag nach der OP mit der **Einstellung 0-60** angewendet werden.

AB DER 2. WOCH

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** in der Ordination. Die physikalische Therapie kann nun begonnen werden. Hier wird die Schiene auf 0-60 umgestellt.

AB DER 4. WOCH

Beginn mit **Infiltrationen** zur Optimierung der Heilung und zum Schutz des Gelenkknorpels sowie zur raschen Wiederherstellung der Gelenksschmiere. Optionen: ACP-PRP in Kombination mit Hyaluronsäure oder isolierte Infiltration mit hochkonzentrierter Hyaluronsäure. Es kann vorsichtig mit Teilbelastung mit 20 kg Körpergewicht begonnen werden. Hier wird ihre Schiene auf 0-90 Grad umgestellt.

NACH 6 WOCHEN

Start mit **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Stabilisierung der Syndesmose – **Syndesmosenrepair**

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Stabilisierung der Syndesmose – Syndesmosenrepair.**

Hier sind für Sie die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (**3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut**) sowie Durchführung von isometrischen Spannungsübungen der Muskulatur.

Bitte tragen Sie Ihren **Aircastwalker**, der Ihnen im Spital angepasst wurde, konsequent.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie** – wir empfehlen **Early Active Rehab** (exklusiv in unserer Ordination)
- › **Nahtentfernung** 10–14 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Stoßwellen-** bzw. **Lasertherapie** zur Unterstützung der Nachbehandlung
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und halbem Körpergewicht für 2 Wochen
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Heilung

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Nachbehandlung bei **Syndesmosenrepair**

Rekonstruktion & Stabilisierung der Syndesmose · Rehabilitationsplan

**Liebe Patientin,
Lieber Patient,**

Bei Ihnen ist eine **Rekonstruktion und Stabilisierung der Syndesmose** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe und Orientierung gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit **Hochlagerung und Kühlung** stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten **14 Tage unterstützend die Krücken** und peilen Sie eine Teilbelastung mit halbem Körpergewicht an.

Der **Aircastwalker** sollte für **6 Wochen Tag und Nacht** getragen werden. Es wird empfohlen, den Aircastwalker regelmäßig zu öffnen und den Fuß zu lüften.

1. WOCH E

Abschwellende Maßnahmen mittels **Game Ready** (ca. 3–5 Einheiten nach OP) sowie **Magnetolithherapie** (ca. 6–8 Einheiten, alle 3–5 Tage in der Ordination).

Zu Hause: Coolpacks und Hochlagerung des Beines. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

2. WOCH E

Im Rahmen der Nahtentfernung: Beginn mit der **Stoßwellentherapie (ESWT)** – 5 Einheiten alle 7–14 Tage in der Ordination.

NACH 6 WOCH E

Abnahme des **Aircastwalkers** und Beginn mit muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen unter Anleitung des Physiotherapeuten/Innen.

AIRCASTWALKER – HINWEIS

Gesamttragedauer: **6 Wochen Tag und Nacht**. Regelmäßiges Öffnen und Lüften des Fußes empfohlen.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und richten sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Endergebnisses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Arthroskopie des Kniegelenks

Nachbehandlung · Wichtigste Punkte im Überblick

Liebe Patientin,
Lieber Patient,

bei Ihnen wurde folgender Eingriff durchgeführt: **Arthroskopie des Kniegelenks.**

Hier sind die wichtigsten Punkte der Nachbehandlung zusammengefasst:

In den ersten Tagen

Hochlagerung des Beines und Auflegen von Eispackungen/Gel-Coolpacks (3× täglich, 20 Minuten, nicht direkt auf die Haut) sowie isometrische Spannungsübungen der Muskulatur. Bitte tragen Sie Ihre Orthese bis zur ersten Kontrolle konsequent Tag und Nacht.

WEITERE MAßNAHMEN

- › Verordnungsschein für **physikalische Therapie** – wir empfehlen **Early Active Rehab** (exklusiv in unserer Ordination)
- › **Nahtentfernung** 10–14 Tage nach OP (bei nicht resorbierbaren Nähten)
- › **Stoßwellen-** bzw. **Lasertherapie** zur Unterstützung der Nachbehandlung
- › **Teilbelastung** mit Stützkrücken und halbem Körpergewicht bis zur Nahtentfernung
- › **Infiltrationen** ab der 4. Woche zur Optimierung der Heilung

MEDIKATION BEI ENTLASSUNG

Sie erhalten ein **Rezept** mit folgender Verordnung:

- › **Voltaren 50 mg Filmtabletten 1-1-1** - für die ersten 2 Tage, dann nur bei Bedarf
- › **Pantoloc 40 mg Filmtabletten 1-0-0** - solange ein Schmerzmittel eingenommen wird
- › **Levenox 40 mg Spritzampullen 1-0-0** - bis zur Vollbelastung

Bei Auftreten von Fieber, starken Schmerzen, zunehmender Schwellung, Rötung oder Überwärmung des Kniegelenkes: **SOFORTIGE KONTAKTAUFNAHME**

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Nachbehandlung nach **Arthroskopie des Kniegelenks**

Rehabilitationsplan · Wochen 1–6

Liebe Patientin, Lieber Patient,

Bei Ihnen ist eine **Arthroskopie des Kniegelenks** durchgeführt worden. Folgende Empfehlungen sind für Sie unterstützend als Merkhilfe gedacht, um den Heilungsverlauf positiv zu beeinflussen.

Allgemeine Hinweise direkt nach der OP

Aktives Strecken in Kombination mit Hochlagerung und Kühlung stehen im Vordergrund. Bitte verwenden Sie die ersten 5–7 Tage unterstützend die Krücken (Teilbelastung mit halbem Körpergewicht). Kniegelenksorthese F 90 Grad bis zur Nahtentfernung Tag und Nacht empfohlen. Zum Duschen kann die Schiene abgenommen werden.

AB DER 1. WOCH

Abschwellende Maßnahmen mittels **Game Ready** (ca. 3–5 Einheiten nach OP) sowie **Magnetolithherapie** (ca. 6–8 Einheiten, alle 3–5 Tage in der Ordination).

Zu Hause: Coolpacks und Hochlagerung des Beines. Duschpflaster können regelmäßig nach Bedarf gewechselt werden.

AB DER 2. WOCH

Beginn mit Bewegungsübungen in der geschlossenen Kette sowie Physiotherapie und Koordinationstraining unter Anleitung. Im Rahmen der Nahtentfernung:

Beginn mit ESWT – 5 Einheiten in der Ordination.

NACH 4 WOCHEN

Beginn mit Infiltrationen zur Optimierung der Heilung, Schutz des Gelenkknorpels und Wiederherstellung der Gelenksschmiere (ACP-PRP + Hyaluronsäure oder isoliert hochkonzentrierte Hyaluronsäure). Zusätzlich vorsichtiges Ergometerfahren (geringe Watt-Zahl, geringe Trittfrequenz, hoher Sattel).

NACH 6 WOCHEN

Beginn mit Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren im Freien, Aquajogging und muskelstabilisierenden Übungen unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

Zusätzlich Beginn mit lockerem Laufen sowie zunehmenden **muskelaufbauenden Kraft- und Stabilisierungsübungen** unter Anleitung der Physiotherapeuten/Innen.

Alle Zeitangaben sind Richtwerte und orientieren sich nach individuellen Gegebenheiten. Bei all den empfohlenen Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen in Anlehnung an die rezente Literatur zur Optimierung des Heilungsprozesses. Es wird bei den genannten Sportarten kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Unser gesamtes Team steht Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.



Dr. El Marto
Knie- und Sportverletzungen



OA Dr. med. univ. Shady El Marto WDM

Facharzt für Orthopädie und Traumatologie | Facharzt für Unfallchirurgie

Am Hof 11 Top 9 | 1010 Wien | Tel.: **+43 664 328 44 65**

ordination@dr-elmarto.at | www.dr-elmarto.at
